

 침구의학 SUMMARY 공지사항

- 시험문제는 주로 질환 비교나 치료법(치료혈) 위주로 나옵니다.
- 회색 설명은 딱히 중요하지 않습니다.

 침구의학 SUMMARY 사용법

- 추가 설명: 회색
- 기출: 빨간색

* 오늘의 진도

[제 3장. 소화기계 질환]

- 제 10절. 변비
- 제 11절. 창만
- 제 12절. 적취
- 제 13절. 황달
- 제 14절. 협통
- 제 15절. 울증

- 똥이 안나온다고 변비가 아니라 하루에 한번씩 보더라도 조금씩 나오고 잘 나오지 않는 경우도 변비이다.

- 대체로 가스와 함께 발생하는 경우가 많고, 8-90프로는 대장 문제이지만 노년층에서는 파킨슨병과 같이 전체적인 근육의 힘이 떨어지면 소화기계의 연동 운동도 감소한다. 해당 문제는 근육의 연동 운동을 회복하는 방향으로 치료해야 한다.

제 10절. 便秘변비(大便秘結, 脾約, 大便不通, 大小便不通)

1. 개요

· = 脾約비약, 大便難대변난

· 증상

- ① 분변(糞便)이 건결하여 배변이 곤란 ((대변을) 딱딱하게 봄)
- ② 장내에 분변이 오래 적체되어 배변주기가 길어지는 경우 (너무 오래 보지 않음)
- ③ 배변은 정상적이나 불창(不暢)한 증상 (보기는 하는데 시원치 않음)
- 기전: 대장의 정상적인 전도(傳導)기능이 상실된 것. 혈중에 조열이 잠복하여 진음(眞陰)이 모산(耗散)되고 진액이 고갈되어 유발

· 원인

- ① 조열로 인한 진액손상
- ② 노권내상과 연로체쇠(年老體衰)로 인한 기혈부족
- ③ 정지실조(情志失調)로 인한 기기울체
- (장뿐만 아니라) 신, 폐, 비위와도 밀접한 관련

2. 서양의학적 이해

1) 변비

- 배변 횟수가 3~4일에 1회 미만으로 감소하는 경우, 딱딱한 변, 배변 시 과도한 힘주기, 불완전한 배변감, 직장이나 항문의 폐쇄감

2) 변비의 진단기준

- ① 배변의 1/4에서 배변시 무리한 힘이 드는 경우
- ② 대변이 과도하게 굳은 경우
- ③ 불완전 배변감이 있는 경우
- ④ 항문직장 폐쇄감이 있는 경우

- ⑤ 배변을 용이하게 하기 위한 손동작이 필요한 경우
- ⑥ 일주일에 3번미만의 배변 횟수
- 6가지 중 2개 이상이 지난 12개월 중 적어도 12주 이상 양성인 경우 기능성 변비로 진단

3) 동반증상

- 복통, 복부 팽만감, 조기 포만감(장이 차있으므로), 고창감, 잦은 방귀, 오심, 속 쓰림, 식욕부진, 불면증, 우울증, 구강 이물감, 두통, 허약 등

4) 원인

- 대장/직장 운동의 이상, 배변 감각/반사의 둔화, 항문의 기질적/기능적 폐쇄 등
- 섬유질이 부족한 식생활, 육체/정신 장애로 인한 활동저하, 배변반사의 자의적 억제, 여행 등 생활환경의 변화, 개인의 성격 등
- +) 특히 장은 심리적 부분과 연관 多
- ex. 과민성 장 증후군
- 강박적, 완벽주의적인 성격인 사람이 장이 안 좋은 경우 많음

5) 특발성/이차성 변비

- ① **특발성 변비** (90%): 뚜렷한 원인이 밝혀지지 않은 것
- +) But 원인을 '못' 찾는 것일 수도
- 대장/직장항문의 운동기능 이상으로 유발
- 과민성장증후군: 주로 청장년에서 발생 / 하복부에 심한 복통 동반, 작고 딱딱한 변, 불완전한 배변감, 배변 시 힘이 많이 들
- 대장무력증: 대장 통과시간 지연 (72h 이상 cf. 정상: 18~72h) → 배변 횟수 감소
- 기능성 출구폐쇄증: 원위부 대장에서 대변을 항문 밖으로 밀어내지 못함 / 배변 시 과도한

힘이 들. 배변 시 골반저 근육 이완이 잘 안되고, 오히려 외괄약근 수축 일어나기도 함

· ② **이차성 변비**: 질환이 있어서 대변을 못 보는 것

- 대장의 국소적 질환: 대장협착, 대장종양, 허혈성 대장염, 치질, 항문협착 등
- 전신적 질환: 내분비 및 대사질환, 교원성 질환, 신경계질환 등
- 기질적 변비(임신, 월경 주기의 황체기 등), 약물로 유발된 변비

6) 치료

- "매일 배변해야 한다는 강박관념은 잘못된 & 3일에 1번 배변하면 정상"이라고 반복 교육
- ① **식이요법**
 - 하루 200cc잔으로 6-8잔 분량의 수분 섭취
 - 매일 25-30mg의 섬유소 섭취
- ② **행동요법**
 - 대장의 운동은 아침 or 식사 후에 가장 활발 ⇒ 아침 식사 시, 음료수 복용 5-15분 후에 변기에 앉아 일정시간 보내도록 함
- **생체 되먹이기 요법**
 - 기능성 출구폐쇄가 있을 때, 배변 시 골반저가 수축보다 이완할 수 있게 근육을 재교육 ∴ 골반저 근육이 이완돼야 대변이 나올 수 있으므로
- **정신심리요법**
- **약물요법**

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 허·실 변비

· ① 실증

- **증상:** 大便閉結대변폐결, 腹部脹滿복부창만, 腹痛拒按복통거안, 煩躁口渴번조구갈, 尿赤뇨적
- **치법:** 調胃清降조위청강
- **치료혈:** 中脘중완 天樞천추 足三里족삼리 風池풍지 內庭내정
- 기해, 기체에 담경의 혈자리를 주로 사용한다.

· ② 허증

- **증상:** 形枯神衰형고신쇠, 肌肉消瘦기육소수, 大便秘結대변비결
- **치법:** 益陰潤燥익음윤조
- **치료혈:** 三陰交삼음교 復溜부류 照海조해 支溝지구 足三里족삼리 大腸俞대장수 太衝태충 太谿태계

(2) 분류

· ① 열비(熱秘)

- **원인:** 腸胃素有積熱장위소유적열, 或熱邪轉入혹열사전입, 熱搏傷津열박상진, 腸胃燥結장위조결, 腑氣不能下行부기불능하행
- 실증+열증 같이 나타남
- **증상:** 便行堅實변행견실, 煩熱口臭번열구취, 時欲飲冷시욕음냉, 口舌生瘡구설생창, 脈數有力맥삭유력
- **치법:** 清泄積熱청설적열
- **치료혈:** 照海조해(補) 支溝지구·曲池곡지(均瀉)
- +) 변비 대응혈: 조해, 지구, 관원, 천추

· ② 기비(氣秘)

- **원인:** 思慮抑鬱사려억울, 氣結不舒기결불서, 肝木失於振振간목실어진창, 或食滯氣鬱不行혹식체기울불행 – 스트레스, 기기울체로 나타나는 증상들
- **증상:** 脘腹時脹時減완복시창시감, 脇肋脹脹협늑진창, 噫氣頻作애기빈작, 脈沈或弦맥침혹현
- **치법:** 降氣開鬱강기개울
- **치료혈:** 氣海기해·大敦대둔(均瀉)

· ③ 풍비(風秘)

- **증상:** 乾咳건해, 咽痛인통, 爪枯膚燥조고부조, 便行燥弦변행조현, 脈浮弦맥부현
- +) 감기 걸렸을 때 열 많이 나면 진액 손상되는 것과 연관
- **치법:** 祛風潤燥거풍윤조
- **치료혈:** 風門풍문·風府풍부·合谷합곡(均瀉)
- +) 풍의 증상이 같이 나타남 ⇒ 풍부, 합곡

· ④ 식비(食秘)

- **증상:** 腹痛胃呆복통위매, 噯暖食臭애난식취(냄새나는 트림), 頻放失氣빈방실기(냄새나는 방귀), 口脣乾焦구순건조, 胸痞欲嘔흉비욕구, 苔厚膩태후니, 脈滑而緊맥활이긴
- **치법:** 祛積導滯거적도체
- **치료혈:** 中脘중완·足三里족삼리(均瀉) 章門장문(補)

· ⑤ 냉비(冷秘)(양허(陽虛))

- **원인:** 陽氣不足양기부족, 下焦虛冷하초허랭, 陰凝固結음응고결, 津液不通진액불통, 致腑氣閉塞지부기폐색
- **증상:** 腹痛喜煖복통희난, 面白溲清면백수청, 脈沈遲맥침지
- **치법:** 溫陽而散寒온양이산한
- **치료혈:** 關元관원·三陰交삼음교(均灸)

· ⑥ 허비(虛秘)(음허(陰虛))

- **원인:** 病後重亡津液병후중망진액, 新生臍氣血未復신생부기혈미부, 發汗而小便過多발한이소변과다, 或平素陰虛虛弱평소음허, 精血固燥津液정혈고조진액, 不能濡潤臟腑불능유윤장부, 臍氣乾固부기건고
- **증상:** 眩暈心悸현훈심계, 形羸失眠형리실면, 虛煩口燥허번구조, 舌有薄苔설유박태, 脈細澁맥세삼
- **치법:** 益血而潤腸익혈이윤장
- **치료혈:** 膈俞격수·肝俞간수(均補)

(2) 대변비결(大便秘結)

- **증상:** 常常乾燥而艱難放下상상건조이간난방하 (항상 건조해서 잘 나오지 않음)
- **치법:** 通泄腸胃臍氣통설장위부기
- **치료혈:** 大腸俞대장수 支溝지구 足三里족삼리 照海조해 太白태백 孔最공최 長強장강. 혹 神門신문(灸: 신경성 변비)

(3) 비약증(脾約證)

- **원인:** 傷寒陽明病상한양명병, 自汗出자한출, 小便數소변삭, 津液內竭진액내갈. 胃強脾弱위강비약
- **증상:** 大便秘難대변비난, 小便數소변삭 (대변은 잘 안 나오고, 소변은 잘 나옴)
- **치법:** 滋養陰血자양음혈, 清脾土청비토
- **치료혈:** 商丘상구 三陰交삼음교

(4) 대변불통(大便不通) - 대변이 아예 나오지 않음

- **원인**
 - ① **대장협열(大腸挾熱):** 熱邪入裏則胃有燥糞열사입리즉위유조분, 三焦伏熱則津液中乾삼초복열즉진액중건
 - ② **대장협냉(大腸挾冷):** 虛人藏冷而血脈枯허인장냉이혈맥고, 老人腸寒而氣道澁

노인장한이기도삼

- ③ **숙식유체(宿食留滯):** 腹脹痛悶복창통민, 胸痞홍비, 欲嘔욕구
- ④ **풍기번작(風氣燔灼):** 腸胃受風장위수풍, 潤燥秘澁고조비삼
- ⑤ **기불하강(氣不下降):** 穀道難곡도난, 噫逆애역, 泛滿證범만증
- **증상:** 累日不得通누일부득통, 閉塞脹滿폐색창만
- **치법:** 流行肺氣유행폐기, 益陰潤腸익음윤장
- **치료혈:** 三間삼간 承山승산 太白태백 大鐘대종 足三里족삼리 湧泉용천 崑崙곤륜 照海조해 章門장문 氣海기해 小腸俞소장수 太谿태계 大腸俞대장수

(5) 대소변불통(大小便不通) - 대소변 둘 다 안 나오는 것. 삼초의 병

- **원인:** 陰陽關格음양관격, 三焦約之病삼초약지병
- **증상:** 大小便不通대소변불통
- **치법:** 利水通腑이수통부
- **치료혈:** 大都대도 水道수도 膀胱俞방광수 小腸俞소장수 大腸俞대장수
 - 부인 산후 복창·대소변불통(婦人產後腹脹大小便不通): 氣海기해 足三里족삼리 關元관원 三陰交삼음교 陰谷음곡
 - **관격토역(關格吐逆):** 先灸 氣海기해·天樞천추, 吐止 然後 用 益元散익원산
→ +) 관격토역: 소변도 대변도 보지 못하면서 구토까지 멎지 않는 것
→ +) 익원산: 구토 후 진액 보충의 의미로 씀

* 침구 치료 첨언

- 70대 할아버지가 단전호흡하다가 갑자기 배가 부풀어 올라서 상기병인줄 알았는데, 진맥을 해보니까 횡행 장관이 좋지 않아 부풀어 있는 상태였다.
- 이런 경우에 침을 놓으면 잠깐은 좋아지는데, 구병이었기에 약을 권유했지만 그냥 침만 맞는다고 하셨다.
- 일침삼약이라고 내과질환에서 침은 단기적인 효과를 보이지만 장기적인 효과에는 약이 유리하긴 하다.

*** 복부 진단 첨언**

- 복부를 진단하는데 있어서 촉진만이 검사가 아닌 시진과 문진도 중요하다.
 - 맥진을 통해 한열허실만을 볼 수 있는 것이 아닌 장기의 상태도 알 수 있다.
- 예를 들어 스트레스를 간맥에서(촌관척 중에 간에 해당하는 맥인듯) 긴맥이 나타나는 것을 볼 수 있다.

제 11절. 脹滿창만

1. 개요

- = 고창(鼓脹, 蠱脹)
- 복과 같이 **복부만 창대(脹大)하고 얼굴(面), 눈(目), 사지(四肢)에는 부종이 없는 것**
- 심하면 복피(腹皮)에 청근(靑筋)이 폭로(暴露)됨: 복수가 있는 경우
- **원인 및 병리**
 - 칠정내상, 육음외침(六淫外侵), 주식실절(酒食失節), 기거부절(起居不節), 방로과다, 혈흡충(血吸蟲) 감염 등으로 발생
 - 정기가 허하여 비토지음(脾土之陰)이 수상(受傷) → 수곡불능운화(水穀不能運化) → 양자승(陽自升) 음자강(陰自降) → 청탁(淸濁)이 혼란, 기화(氣化)는 탁해짐, 혈어울위열(血瘀鬱爲熱) → 열과 기화로 생긴 습이 상생하여 창만 발생
 - 병리상 간, 비, 신 3장의 병변으로 기, 혈, 수(水) 등이 복내(腹內)에 적체되어 생김
- **주증상:** 中滿중만(배가 부풀어있고 그득함), 肚腹脹두복창 등
- **치료:** 補中보중, 行濕행습, 消導소도
- **감별**
 - **부종(浮腫):** 음식을 평소와 같이 섭취 (cf. 창만: 음식 섭취 못함)
 - **비만(痞滿):** 내각비민(內覺痞悶)하나 외창(外脹; 외부로는 창만X)이 없음 (cf. 창만: 내창하면서 외창이 있음)
 - **수종(水腫):** 머리, 얼굴, 사지 모두 부종 / 복부 창만해도 푸른 힘줄은 없음
- 복수를 빼는 것은 환자를 잠깐 편하게 해주지만 금방 복수가 다시 생긴다.
- 침 치료는 보조 수단이고 근원적인 문제를 해결할 필요가 있다.(간질환, 신질환)

2. 서양의학적 이해

1) 창만

- ① 간경화, 결핵성 복막염, 복강 내 악성종양, 신증후군 등으로 인한 복수(ascites)
- ② 기능성 소화불량증, 장폐쇄 등으로 인한 장관내 가스 과다

(1) 복수: 복강내에 이상량(20mℓ 이상)의 체액이 저장된 것. 임상적으로 500mℓ 이상

- **기전:** 혈관벽 밖으로 혈액 속 액체 성분이 삼출 → 복강 내에 과량의 액체가 축적됨
- 몸 전체의 염분·수분의 부적절한 과잉축적 상태
- 심한 간 질환 환자에서 가장 흔함: 간경변증(간경화), 미만성실질성간질환
- 혈구희박(hemodilution), 부종, 림프를 동반할 때가 많음
- **원인**
 - 복강영역/전신의 정맥압항진(문맥압항진 등), 저단백혈증에 의한 혈장교질삼투압의 저하, 복막의 염증 또는 종양 등
 - 삼출액(exudate, 단백질 함량↑)과 여출액(transudate, 단백질 함량↓)으로 구별
 - **문맥압 항진에 의한(SAAG 상승):** 간경변증, 우심부전, 간내담전이, 알코올성 간염, 결핵성 복막염이 병발한 복합성 복수도 포함
 - **기타:** 복막에의 암전이, 결핵성 복막염, 췌장성 복수, 교원질환에 기인한 장막염 등
- **진단**
 - **복부의 윤곽 관찰:** 국소 종창인지 vs. 전체 종창인지 감별
 - **복부의 특징적 소견:** 복부가 팽팽하게 팽만되어 있으며, 피부가 단단히 퍼져 있고, 옆구리가 돌출되어 있으며, 배꼽이 뒤집혀 있는 것
 - **원인 질환에 따른 특징**

→ **문맥압 항진증**: (메두사 머리처럼) 혈액 흐름 방향이 배꼽을 중심으로 밖으로 향하는 뚜렷한 복부 정맥(=청근) 소견

⇒ **n 간이 부드럽게 촉진되는 경우**: 간 외의 원인으로 인한(간의 문제X) 문맥압 항진 가능성 높음

⇒ **n 간이 단단하게 촉진되는 경우**: 간경변증 가능성 높음

→ **하대정맥의 폐쇄**: 복부의 하부 → 배꼽으로 향하는 정맥측로혈행

→ **장폐색, 팽만**: 장의 고리로 인해 능선이 보이며, 복부가 돔 형태

→ **유문부 협착**: 좌측에서 우측으로 진행되는 뚜렷한 연동운동, 심와부에서 종괴 촉진

⇒ +) 협착이 있으므로, 협착을 뚫어내기 위해 과도하게 운동

→ **전이성 간**: 호흡에 따라 움직이는 우상복부 종괴

(2) 장관 과다가스

· **장관내 가스**: 장관 내에 존재하는 기체의 총칭

- **생성**: 공기의 연하, 장관내에서의 가스 생성(가장 多), 혈액으로부터의 확산

· **장폐쇄가 있을 경우**: 장관내 가스의 배출 원활X → 과다 축적될 수 있음

- **장폐쇄**

→ **구분**

⇒ ① **기계적 폐쇄**: 실제로 장관이 폐색됨

⇒ ② **마비성 폐쇄**: 소화관의 운동이 소실되어 발생

→ 주로 복부 팽만감과 함께 간헐적으로 쥐어짜는 복통, 구토 등이 동반됨

· **임상적 가스증후군**

- **잡은 트림**: 정서적 긴장, 흥분질환, 복부질환(소화성궤양이나 역류성 식도염 등)으로 오기도 하나, 대부분 기능적 → 공기를 삼켜 트림한다는 것 주지시킴

- **복부팽만감**: 가스 양/성분은 차이가 없으나, 장관벽의 확장에 대한 감수성 증가나 장관운동의 이상에서 기인하는 것으로 추정 - 가스 과다 생성은 대장보다 소

장 쪽 기능이상

→ +) 장관벽의 확장에 대한 감수성 증가: =장쪽의 감각신경이 예민해진 경우

→ +) 트림, 복부팽만감은 소화기 쪽 치료하면 호전됨

- **간,비굴곡 부위 증후군**: 대장 굴곡부위에 가스가 고여 대장이 확장되어 상복부 통증이 일어나리라 추정 → 변비치료

- **잡은 방귀**: 기질적(기저) 질환 있는 경우는 드물. 흡수되지 않은 탄수화물, 특히 콩 종류가 혐기성 대장세균의 발효과정에 의해 가스생성 증가시킴

- **가스-블로우트 증후군**: 역류성 식도염으로 위저부 추벽 성형술을 받은 후 트림/구토 불가능 / 복부팽만, 복통, 과도한 방귀 등 / 시간 지나면 호전됨 (장 치료하면 호전)

- **탄수화물 흡수장애군**: 유당, 과당, 전분 등 탄수화물이 소장에서 흡수장애로 인해 대장내에서 세균의 발효에 의해 가스가 발생 / 복통, 방귀, 고창 등 호소

- **대장내 가스폭발(드물)**: 대장내 수소, 메탄성분 과도하면 장내 가스 폭발, 천공 가능

· 기질적 질환 감별. 복수/종괴 등도 감별 필요

· **문진**: 식이습관(가스를 많이 생성하는 콩, 사과, 자두, 건포도, 전분, 과당 많이 들어간

껌이나 음료 등), 약제복용(**장관운동 억제할 수 있는** 마약, 항콜린제, 칼슘차단제), 과거 수술력 등

- +) 수술 후 유착으로 가스 생성되는 경우 생각보다 많음: 제왕절개/맹장수술/복부 쪽 수술 → 복부 쪽 유착 → 장의 운동성 저하 → 가스 생성 ⇒ **유착을 해결 해줘야 함**

· **치료**

- 장내가스를 줄이거나, 장관운동장애가 있으면 호전시키는 것이 가장 중요

- 공기연하를 줄이기 위해 껌, 캔디 금하고, 금연, 구강내 청결하게 하고, 불안증 치료

- 탄수화물 흡수장애 시: 콩, 과일, 전분 섭취 ↓

- 유당흡수장애 시: 우유를 금함(발효유로 대신함)
- 장운동 촉진

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 기본 침구치료: 足三里족삼리 中脘중완 氣海기해

(2) 변증치료

· ① 허창(虛脹): 눌러보면 말랑말랑한 것

- 원인: 陰寒爲邪음한위사

- 증상: 吐利不食토리불식, 時脹時減시창시감, 腹脹無痛복창무통, 按之陷而軟안지함이연, 便泄변설

- 치법: 健運脾土건운비토

- 치료혈: 中脘중완 天樞천추 太白태백 足三里족삼리 氣海기해 脾俞비수 胃俞위수, 大腸俞대장수(灸)

· ② 실창(實脹)

- 원인: 陽熱爲邪양열위사

- 증상: 身熱신열, 咽乾인건, 常脹內痛상창내통, 按之則不陷而硬안지즉불함이경, 便閉변폐, 小便赤소변적

→ +) 실질적으로 안이 짝 차있어서 통증도 있을 수 있고(상창내통), 누르면 들어가지 않음(안지즉불함이경)

- 치법: 通降脾胃통강비위, 清胃熱청위열

- 치료혈: 大腸俞대장수 足三里족삼리 天樞천추 內庭내정 曲泉곡천 次髎차료

· ③ 기창(氣脹)

- 원인: 七情鬱結칠정울결

- 증상: 身體腫大신체종대, 四肢瘦削사지수삭, 或腹滿혹복만, 膚色不變부색불변, 噫氣或轉失氣則舒애기혹전실기즉서, 脘脇痞滿완협비만, 小便短黃소변단황, 大便秘結대변비결, 苔薄白태박백, 脈弦細맥현세

- 치법: 調氣조기, 理氣寬中이기관중

- 치료혈: 膻中단중 中脘중완 氣海기해 太衝태충 足三里족삼리 內關내관 建里건리, 胃俞위수

→ ① 변비(便秘): 加 腹結복결

→ ② 협통(脇痛): 加 支溝지구·陽陵泉양릉천

→ ③ 뇨황(尿黃): 加 陰陵泉음릉천

· ④ 혈창(血脹)

- 증상: 婦人多發부인다발, 小腹悶痛소복민통, 小便利소변리, 大便黑대변흑, 煩燥번조, 嘔逆구역, 面黃면황, 肌瘦기수 或脘腹脹大堅硬혹완복창대건경, 臍周靑筋暴露제주청근폭로, 脇下癥結협하징결, 痛如鍼刺통여침자, 潮熱조열, 口乾不欲引飲구건불욕인음, 舌質紫暗설질자암, 脈細弦或澁맥세현혹삽

→ +) 소변은 잘 나오면서(소변리), 대변은 까맣고(대변흑), ... 제주의 청근도 노출되고(제주청근폭로), 협하에 종괴가 느껴지고(협하징결), 통증이 침으로 찌르는 것 같고(통여침자) ...

- 치법: 疏通肝脾소통간비, 活血化瘀활혈화어

- 치료혈: 血海혈해 膈俞격수 中極중극 章門장문 期門기문 肝俞간수 中封중봉

→ ① 진창(臍脹)(부풀어오르고 창만이 있을 때): 加 梁門양문

→ ② 황달(黃疸): 加 陽剛양강·腕骨완골

→ ③ 조열(潮熱): 加 太谿태계·膏肓고황

· ⑤ 수창(水脹): 안에 물이 차있는 것

- 증상: 腹部脹大如蛙복부창대여와, 按之凹陷안지요함. 或有下肢水腫혹유하지수증, 脘腹臌脹완복진창, 面色滯黃면색체황, 怯寒겁한, 神倦신권, 小便不利소변불리, 大便糖薄대변당박, 苔薄膩脈沈緩태박니맥침완

→ +) 복부창대여와: 개구리처럼 볼록 튀어나와 있음 / 안지요함: 누르면 들어가는 함 / 혹유하지수증: 하지 쪽 수증이 있음

- 치법: 健脾益腎건비익신, 調氣行水조기행수

- 치료혈: 脾俞비수 腎俞신수 水分수분(灸) 復溜부류 公孫공손

→ 主 족태음·족소음·임맥, 加 배수혈. 침구사법

→ ① 대변당박(大便糖薄): 加 天樞천추·上巨虛상거허

→ ② 겁한(怯寒): 加 命門명문·氣海기해수(灸)

· ⑥ 곡창(穀脹)

- 원인: 失飢傷飽실기상포

- 증상: 痞悶停酸비민정산, 朝食能食조식능식, 暮則不能食모즉불능식

→ +) 조식능식 모즉불능식: 아침엔 능히 먹을 수 있는데 저녁 되면 못 먹음

- 치법: 消積導滯소적도체

- 치료혈: 中脘중완 天樞천추 胃俞위수 脾俞비수 內庭내정

4. 고찰

· 부종 vs. 창만: 음식을 먹을 수 있느냐/없느냐

└ 부종: 음식여상(飲食如常)

└ 창만: 비기극허(脾氣極虛)로 음식 섭취하지 못함

- +) 복수 차 있으면 음식 못 먹음

· 간경화와 한의학의 고창(鼓脹), 단복창(單腹脹), 징하적취(癥瘕積聚) 등과 유사·음식부절, 음주과다, 방로과다, 혈흡충증 등이 원인

· 병리상 간, 비, 신 3장이 병을 받아 氣, 血, 水 등이 복내에 적체되면서 창만

└ 허창(虛脹): 按之則陷而軟안지즉함이연(눌렀을 때 부드러우면서 쑥 들어감) 便泄변설·

└ 실창(實脹): 按之則不陷而硬안지즉불함이경(눌렀을 때 들어가지 않고 단단함) 便閉변폐

제 12절. 積聚적취

1. 개요 . = 복강내의 적괴(積塊). 적(積) / 취(聚)로 구분

	원인	특징	부위	병리	병기	치법
積	陰氣 음기	沈而伏침이복, 有形유형, 始發有常處시발유상처, 固定不移고정불이, 痛有定處통유정처, 깊은 곳에 있으면서, 나타난 자리에 항상 있고, 통증의 위치가 이동하지 않는 것 부위가 상하로 종시(終始)가 있고 좌우로 窮(궁)함	屬血分 속혈분, 臟病 장병 (오장)	氣血瘀滯成積 기혈어체성적 正氣日損 정기일손	병기 비교적 길고 중병(重病)에 속함	活血활혈 祛瘀거어 理氣이기 扶正부정 軟堅연건
聚	陽氣 양기	浮而動부이동, 無形무형, 始發無根本上下 시발무근본상하, 떠있으면서 움직이는 것, 근본과 상하가 없이 생김 時聚時散시취시산 (그 부위가 유지(留止)하는 곳이 없음), 痛無定處통무정처	屬氣分 속기분, 腑病 부병 (육부)	氣結不行 기결불행 或 兼痰食停滯 겸담식정체 疝瘕식정체 正氣未傷 정기미상	병기 비교적 짧고 경병(輕病)에 속함	疎肝소간 理氣이기 化痰화담 活血활혈

· 원인: 신형허중(身形虛中), 한열실조(寒熱失調), 육울칠정상(六鬱七情傷), 음식내상(飮食

內傷), 기체혈어(氣滯血瘀), 담체(痰滯) 등

· 병리: 장위(腸胃)의 락맥이 상함 → 혈일장외(血溢腸外) → 장 외부의 한랭한 진액과 상박하여 병합, 응취(凝聚) → 적취형성

2. 서양의학적 이해

· 촉진으로 증상 관찰 가능

· 간비종대, 기계적 장폐쇄, 유문폐쇄, 복강내종양, 증식성 장결핵, 장기능 문란, 내장하수 등과 연관

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 오적(五積) - 각각의 위치는 그 장부들이 위치한 곳

· ① 간적(肝積)

- 이명: 肥氣비기

- 증상: 在左脇下재좌협하, 如覆盂여부배, 有頭足유두족, 久不癒구불유, 令人發咳逆영인발해역(一云脇痛일운협통)痰癰해학, 連歲不已연세불이, 面靑면청, 脈弦而長 맥현이장

→ +) 좌협하에 있으면서(재좌협하), 잔을 엮어놓은 듯한 모양(여복배), 두족이 있으면서(유두족), 오랫동안 낫지 않고(구불유), 사람으로 하여금 해역, 해학을 유발(영인발해역해학), ...

- 치법: 養正양정, 消積소적, 調氣조기

- 치료혈: 章門장문 行間행간 膈俞격수 肝俞간수 期門기문(간의 모혈)

→ 寒熱吐逆한열토역: 加 足三里족삼리·大椎대추

· ② 심적(心積)

- 이명: 伏梁복량

- 증상: 起臍上기제상, 大如臂대여비, 上至心下상지심하, 久不癒令人煩心구불유령인번심, 面赤면적, 脈數實맥삭실

→ +) 제상에서부터 생겨서(기제상), 크기가 팔뚝만 하고(대여비), 심하에까지 이르면서(상지심하), 오랫동안 낫지 않으면 사람으로 하여금 번심, 면적, 맥삭실한

증상이 나타남(구불유령인번심, 면적, 맥삭실) ...

- **치법:** 養正양정, 消積소적, 調氣조기

- **치료혈:** 心俞심수 膈俞격수 大陵대릉 三陰交삼음교 行間행간 足三里족삼리 上脘상완

· ③ 비적(脾積)

- **이명:** 痞氣비기

- **증상:** 在胃脘재위완, 覆大如盤부대여반(一作盂일작배), 久不癒令人四肢不收구불유령인사지불수, 發黃疸발황달, 飲食不爲肌膚음식불위기부, 面黃면황, 脈大而虛맥대이허

→ +) 위완부에 있으면서(재위완), 쟁반/잔을 얹어놓은 것 같고(복대여반(일작배)), ... 사지불수, 황달 ...

- **치법:** 養正양정, 消積소적, 調氣조기

- **치료혈:** 足三里족삼리 內庭내정 陷谷함곡 脾俞비수 行間행간 中脘중완 痞根비근 → 괴지상하좌우(塊之上下左右)에 침구(鍼灸): 종괴의 상하좌우에 침구해주면 더 좋음

· ④ 폐적(肺積)

- **이명:** 息賁식분

- **증상:** 在右脇下재우협하, 覆大如盂부대여배, 久不癒令人酒淅寒熱喘咳구불유령인주석

한열천해, 發肺癰발폐옹, 面白면백, 脈數而浮맥수이부

→ +) 우협하에 있으면서(재우협하), 잔을 얹어놓은 것 같고(복대여배) ...

- **치법:** 養正양정, 消積소적, 調氣조기

- **치료혈:** 肺俞폐수 經渠경거 足三里족삼리 豐隆풍릉 內關내관 巨闕거궐 章門장문, 期門기문

· ⑤ 신적(腎積)

- **이명:** 奔豚분돈

- **증상:** 小腹上至소복상지, 心下若豚狀심하약돈상, 或下或上無時혹하혹상무시, 久不已

令人喘逆骨痠少氣구불이령인천역골위소기, 面黑면흑, 寸口脈大實촌구맥대실

→ +) 소복에서 일어나서 심하까지(소복상지 심하), 돼지가 깨어난 것처럼 위로 확 치밀어 오름(약돈상)

- ex. "아랫배에서부터 치밀어 올라 불이 올라오는 것 같다"라고 표현

- **치법:** 養正양정, 消積소적, 調氣조기

- **치료혈:** 三陰交삼음교 腎俞신수 章門장문 中極중극 湧泉용천 關元관원(灸)

+))

· **적:** 촉진 가능한 것

- ex. 간경화, 간암, 위암, 복강암, 복막암, 하복부 자궁근종 (심한 경우)

· **취:** 단단하게 촉진되진 않고, 말랑말랑하게 이동하는 것처럼 느껴지는 것

- ex. 위 폐쇄, 위하수

제 13절. 黃疸(황달)

1. 개요

· **주요증상:** 목황(目黃, 공막(흰자 부위)), 부황(膚黃, 피부), 뇨황(尿黃, 소변)

· **양황 vs. 음황**

- **陽黃**

→ 간담(肝膽)에 외감습열(外感濕熱)이 쌓여 습열울증(濕熱鬱蒸)하여 소설(疏泄)기능 저체, 담즙이 넘쳐 발생

→ 대부분 외감에 속함, 병정 짧음 (급성): ex. 급성 간염, 담도 폐색

→ 선명한 황색 / 열증, 실증

- **陰黃**

→ 주식부절(酒食不節)로 기포(饑飽)하거나 사려노권(思慮勞倦) 과도로 비위 손상, 습울기체(濕鬱氣滯), 간담어적(肝膽瘀積)하여 담즙의 배출이 용이하지 못해 발생

→ 대부분 내상에 속함, 병정 비교적 깊: ex. 심각한 병(간경화, 간암, 담관암 등)

→ 황색이 회암(晦暗, 어두컴컴, 예쁘지 않은 노란색) / 허증, 한증

· **원인**

- ① **음식부절(飲食不節)** → 비위운화실상(脾胃運化失常) → 습열내울(濕熱內鬱)

→ 구이불설(久而不泄) ⇒ 유일피부소치(流溢皮膚所致; 피부 바깥으로 나오면서 나타남)

- ② **기음취와(嗜飲醉臥)**로 인해 당풍수습(當風受濕) → 주습지기(酒濕之氣)가 위 풍사소알(爲風邪所遏)하여 부득발증(不得發蒸) ⇒ 발황(發黃) (≒급성간염)

- ③ **방사과도로** 신기허모(腎氣虛耗) → 수습(水濕) 부득증화(不得蒸化) ⇒ 울이발황(鬱而發黃)

- ④ **한량지제(寒涼之劑)**를 과하게 투여하거나 구병(久病)으로 진양쇠미(眞陽衰未), 노권상기(勞倦傷氣)하여 중기(中氣)가 대허(大虛) ⇒ 습종한화이발황달(濕從寒化而發黃疸)

- ⑤ **그 외:** 유행감모(流行感冒), 복서(伏暑), 유행역려(流行疫癘)

· **참고) 위황(萎黃):** 잘 못 먹어서 누렇게 뜨는 것

- 면색이 위황(萎黃)하며 기혈부족지증 / 식체, 충적(蟲積)을 겸한 경우가 많음- 공막과 점막은 발황X (피부만 황달이 생김)

- **변증:** 비허적체(脾虛積滯), 기혈양허(氣血兩虛)

2. 서양의학적 이해

1) 정의

· 혈중 빌리루빈 농도가 증가되는 것 (2mg/dl 이상) · 인체 조직에 빌리루빈이 침착한 후, 황색으로 변색되는 것 (공막, 피부, 점막 부위)

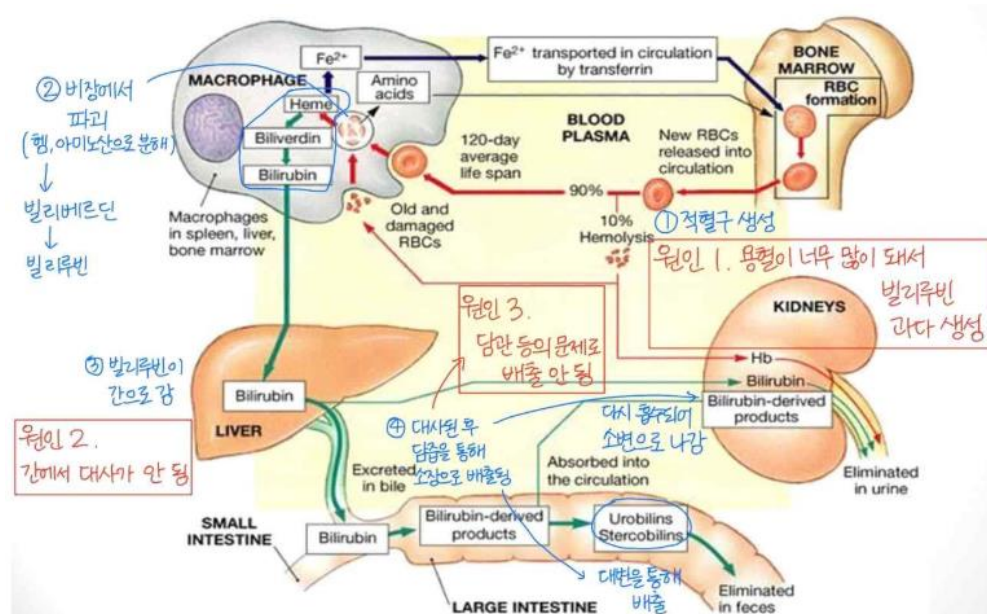
- **빌리루빈** (bilirubin, 담즙색소)

→ 헤모글로빈과 같이 철분을 포함하고 있는 특수 단백질이 체내에서 분해되는 과정에서 생성되는 황색의 담즙색소

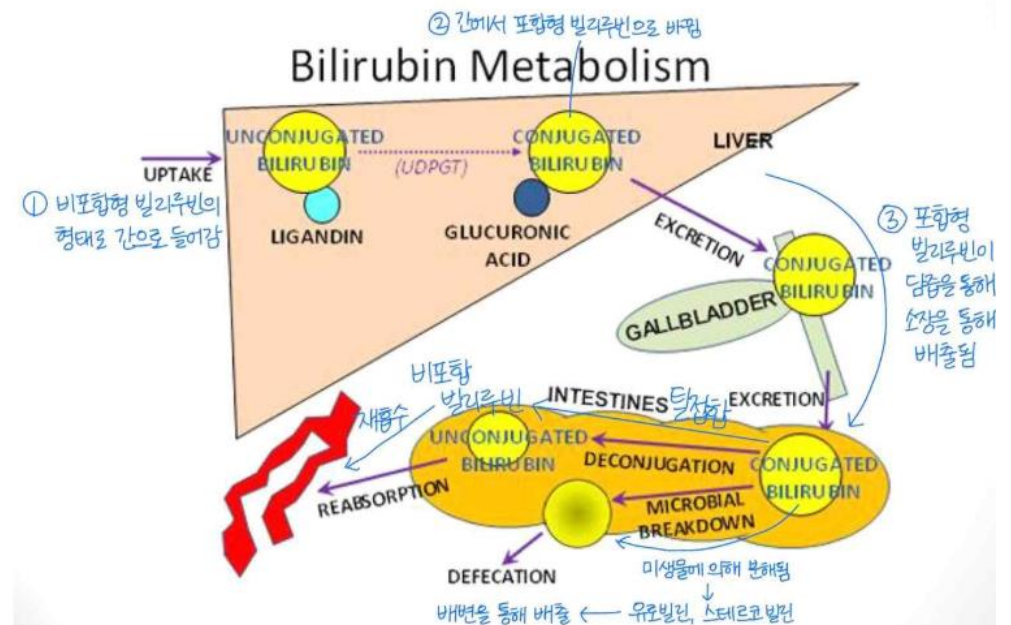
→ 체내에 들어온 물질 분해 과정 중 생성되는 독성 물질로, 보통은 간에서 해독 작용을 거친 후 담즙으로 배설됨

→ 포함형과 비포함형으로 나뉨

2) 기전



- ① 빌리루빈이 체내에서 필요 이상으로 과다 생성
- ② 생성된 빌리루빈이 몸 밖으로 제대로 배출되지 못함



3) 증상

- 소변색이 짙어짐
- 경우에 따라 대변색이 연해지거나, 피부가려움증을 동반

4) 동반증상에 따른 감별

- 피로감, 식욕부진, 구역질 등 동반 → 급성 간염 의심
- 복통, 발열 등 동반 → 염증(담도염 등) 의심
- 전신쇠약, 체중감소와 함께 서서히 발생 → 간, 주위장기의 종양 의심
- *신생아에서 생리적 황달 발생하기도 함 (생후 24h 후 발생, 1~2주 뒤 소실)

5) 분류

	원인	빌리루빈 증가	동반 증상
용혈성 황달 (간전성)	빌리루빈 생산 증가 로 간에서 정상적 생리기능으로 처리하지 못해 발생 (용혈성빈혈 등 혈액질환)	비포합형 빌리루빈 증가	용혈을 동반
간세포성 황달 (간성)	간질환, 수술 후 황달 등 *간질환: 약물에 의한 독성 간염, 바이러스성/알코올성/자가면역성 간염, 간경변증, 윌슨병, 간암 등	비포합형, 포합형 동시에, 또는 어느 한 쪽이 증가	
폐색성 황달 (간후성)	담도의 기계적 폐색 *담도의 기계적 폐색: 담석, 담도암, 협착	포합형 빌리루빈 증가	지방변, 전신소양감 등

· 급·만성 간염, 간경변증, 원발성 간암, 간농양, 지방간, 담관암, 담관결석 등의 간·담도

질환 및 용혈성 질환, 유전성 질환과 약물에 의한 경우에서 관찰됨

· 한의학에서의 황달과 구분 필요

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 양황 및 음황

· ① 양황(陽黃)

- **증상:** 發熱발열, 身重신중, 口渴구갈, 腹滿복만 혹은 膚色鮮如橘色부색선여귤색, 身熱煩渴신열번갈, 心煩胸悶심번흥민, 腹滿脇痛복만협통, 脇部絞痛협부교통, 大便秘結대변비결, 小便短赤소변단적, 舌苔黃膩설태황니, 脈洪滑有力맥홍활유력

→ +) 발열, 신중, 구갈 등 실증 증상

→ +) 부색선여귤색: 피부가 귤색처럼 선명한 색을 띠

- **치법:** 清熱利濕청열이습, 疏肝利膽소간이담, 退黃퇴황

- 치료혈

→ 至陽지양 腕骨완골 肝俞간수 膽俞담수 脾俞비수 혹은 期門기문 日月일월 中脘중완, 三陰交삼음교 章門장문: 양황·음황 공통 혈자리

→ 加 大椎대추 支溝지구 行間행간 陽陵泉양릉천 혹은 太衝태충 陽陵泉양릉천 建里건리 陽綱양강 膽俞담수 委陽위양 大椎대추 陰陵泉음릉천: 실증이므로 추가

⇒ ① 완비(脛痞) 체중감소(體重減少): 加 中脘중완 足三里족삼리

⇒ ② 흉민(胸悶) 오심구토(惡心嘔吐): 加 內關내관 公孫공손

⇒ ③ 복창(腹脹) 변비(便秘): 加 大腸俞대장수 天樞천추

⇒ ④ 열중(熱重): 加 大椎대추

⇒ ⑤ 신혼(神昏): 加 人中인중 中衝중충 少衝소충(放血)

⇒ ⑥ 습중(濕重): 加 陰陵泉음릉천

⇒ ⑦ 완비변당(脛痞便澇): 加 足三里족삼리

· ② 음황(陰黃)

- **증상:** 身重신중, 倦怠권태, 多睡眠다수면, 口不渴구불갈, 身不熱신불열 혹은 膚色晦黃

부색회황, 畏寒少食외한소식, 精神困倦정신곤권, 四肢欠暖사지흠난, 大便稀澇대변희당, 甚則腹脹如鼓심즉복창여고, 脇下癥塊협하징괴, 蛛絲縷縷주사루루, 舌淡苔薄白설담태박백, 脈沈細無力맥침세무력

→ +) 신중, 권태, 다수면 등 허증 증상

→ +) 부색회황: 피부가 어두운 황색을 띠

- **치법:** 健脾化濕건비화습, 益肝理氣익간이기 혹은 行氣活血행기활혈, 退黃퇴황

- 치료혈

→ 至陽지양 腕骨완골 肝俞간수 膽俞담수 脾俞비수 혹은 期門기문 日月일월 中脘중완

三陰交삼음교 章門장문: 양항·음항 공통 혈자리 → 加 足三里족삼리 氣海기해 陰陵泉음릉천 命門명문 血海혈해 혹 腎俞신수 脾俞비수 中脘중완 足三里족삼리 肝俞간수 三陰交삼음교 章門장문: 보해주는 혈 다용

⇒ ① **신피외한(神疲畏寒):** 加 命門명문 氣海기해, 혹 加 命門명문 關元관원

⇒ ② **대변당박(大便糖薄):** 加 天樞천주, 혹 加 天樞천주 關元관원

(2) 기타

· ① 주달(酒疸)

- **원인:** 飲酒常多음주상다, 進食常少진식상소 – 술을 너무 많이 마셔서
- **증상:** 心中熱結而煩심중열결이번, 小便不利소변불리, 足心熱족심열, 不能食불능식, 時欲吐시욕토, 鼻燥비조, 目身黃목신황
- **치료혈:** 中脘중완 足三里족삼리 委中위중 公孫공손 陽陵泉양릉천 三陰交삼음교 至陽지양 肝俞간수 膽俞담수

· ② 곡달(穀疸)(체달(滯疸) · 식달(食疸))

- **원인:** 因胃熱인위열, 大飢過食停滯대기과식정체(과식해서 정체가 생기는 것)
- **증상:** 寒熱不食한열불식, 食則頭眩식즉두현, 心中不安심중불안, 腹脹滿복창만, 發黃발황
- **치료혈:** 足三里족삼리 內庭내정 胃俞위수 中脘중완 至陽지양

· ③ 여로달(女勞疸)(흑달(黑疸) · 색달(色疸))

- **원인:** 大勞대로, 當慾大熱交接당욕대열교접
- **증상:** 額上黑액상흑(이마 위가 까맣게 됨), 微汗出미한출, 手足心熱수족심열, 小便自利소변자리, 寒熱한열, 小腹急滿소복급만, 腹脹복창, 便黑변흑
- **치료혈:** 公孫공손 關元관원 腎俞신수 然谷연곡 至陽지양 脾俞비수 陽綱양강 中極중극

· ④ 황한(黃汗)

- **원인:** 因陽明表熱인양명표열, 汗出時入水浴한출시입수욕
- **증상:** 身腫發熱신종발열, 汗出而渴한출이갈, 汗出染衣한출염의(땀이 옷을 적심), 色正
黃如黃栢汁색정황여황백즙(황백즙과 같은 노란색 땀이 나옴) - 허증 증상
- **치료혈:** 足三里족삼리 公孫공손 陰陵泉음릉천 脾俞비수 中脘중완 至陽지양 腎俞신수, 氣海기해

제 14절. 脇痛협통

1. 개요

· 일측 또는 양측의 협륵(脇肋) 부위 동통

- 협(脇): 측흉부(側胸部). 액하(腋下)에서 제12늑골까지의 부위 총칭

→ 肉(근육)과 骨을 합하여 말한 것 / cf. 늑(肋): 骨부위만을 가리킴

· 대개 간담 2경에 속한다고 봄 (족소양담경맥 유주)

· 심, 비, 폐, 신, 위, 방광의 질환에도 협통 발생

- 협통은 본병(本病)이 아니라, 다병사(多病邪)가 제경(諸經)에 침유(侵留)하여 기역(氣逆)

불해(不解)하면 차결(次結)하여 상전되고 점차 소양결음경으로 전파 → 협늑에 동통 유발

- 노심초사(勞心焦思), 우수사려(憂愁思慮)로 인한 것: 심폐소전(心肺所傳; 심폐에서 전한 것)

- 음식내상, 노권으로 인한 것: 비위소전(脾胃所傳; 비위에서 전한 것)

- 색욕내상(色慾內傷)하여 수도옹폐(水道壅閉)로 인한 것: 신방광소전(腎膀胱所傳; 신·방광에서 전한 것)

· 내장으로부터의 연관통 / 외부 순환의 혈관·신경계통의 통증을 분별 → 내형과 외형의 적절한 치료

2. 서양의학적 이해

1) 협통

· 질환이라기보다, 통증이라는 하나의 증상 (병명이라기보단 증상명!) · 원인: 협부의 외상(늑골골절 등), 대상포진 등에 의해 유발되는 늑간신경통, 담석증 및 늑막염, 폐 질환과 같은 내장 질환의 방사통, 심신증 등

· 표 외에도 만성피로증후군, SLE 등의 자가면역질환, 갑상선질환, 우울증, 심신증 등 정신과 영역에서도 협통 동반

급성 간염	- 간 비대됨, 식욕부진, 오심, 구토, 피로감 등 동반 - +) 간염에서 생각보다 소화불량 많이 호소함 - +) 간 문제로 인한 피로감은 오후에 많이 호소
알코올성 간질환	- 간종대(=간비대)가 주증상 - 권태, 복부불쾌감과 함께 압통 동반하기도 함
간경변증	- 간종대 시 협통, 우상복부통 - +) 촉진했을 때 만져지는 경우도 있음
지방간	- 협통 대부분 없음. But 급격한 지방 침윤 시 발생 가능(∴간 피막을 건드려서. But 흔치 않음)
간세포암	- 우상복부통, 복부종괴, 혈성복수 동반
담석증	- 지속적인 통증이 심와부에서 우상복부로 연결되어 발생 - 심하면 견갑으로 방산 - +) 담석 자체보다도, 담석으로 염증 생겼을 때
담낭염, 담낭암	- 우상복부의 종괴·협통 병발
급성췌장염	- 심와부/배꼽주위 통증 - 종종 가슴/하복부/협부 방사통 - 양외위 시 통증 심 / 상체 구부리거나 무릎 굽히면 호전
만성췌장염	- 우상배부 or 좌상배부에서 심함 - 때로 전흉부/협부로 방사통 - 음주나 과식 시 가중
대장질환	- 상행결장의 궤양성 염증/종양에서 가끔 협통 동반
혈액질환	- 겸상적혈구증후군의 급성 동통 발증으로 발생 가능
만성 기관지염, 폐기종, 천식 등	- 호흡곤란, 객담, 천명, 흉부압통과 함께 협통 동반 - +) ∴횡격막까지 염증이 미치거나 / 기침이 너무 심해 늑간근까지 영향
외부손상, 늑간신경통	- 통증이 국소적, 동작변화에 따라 강도 달라짐 - 심하면 호흡곤란 (∴숨 쉴 때마다 아프므로)
신결석	- 협부에서 갑자기 시작 (정확히 협부보다는 약간 뒤쪽의 신장이 있는 부분에 통증, 요통 동반되기도) - +) 염증 동반되는 경우 감기 증상 올 수 있음 - 서혜부 아래쪽으로 참기 어려운 통증 발생
신세포암	- 혈뇨, 복부종괴, 협통
신우신염	- 빈뇨, 절박뇨, 배뇨통과 함께 협통 발생 - +) 감기 증상과 비슷하게 올
협심증, 율혈성 심부전 등 심장질환	- 흉부, 심와부, 협부의 통증

· +) 피로감의 특징에 따른 원인

- 오전(기상 후): 신장이 약해서(신기허), 수면장애

→ 신장이 약한 사람: 야행성(밤 되면 살아남)

- 오후, 저녁: 간 문제

- 갑상선 기능 저하: 금방 피곤해지고, 좀 쉬면 조금 충전됐다 또 금방 피곤해짐
[배터리가 작은 것]

- 심장이 약함: 출력이 작음 [엔진이 작은 것]

- 빈혈(혈허)

- 염증 (감기 걸리면 피로한 것처럼, 자가면역성 질환(류마티스, 베체트병), 결핵 등 만성 염증 있는 경우)

- "증상을 잘 알아야겠지만, 진맥으로도 간 문제인지, 심장 문제인지 다 알 수 있음"

3) 늑간신경통

· 정의: 늑골 사이의 늑간신경의 손상이나 염증으로 발생하는 늑골 부근의 통증

- *늑간신경: T1-T12 척추신경의 앞가지로 이루어짐

· 특징: 주로 T5-T9 늑간에 나타남 / 여성>남성, 좌측>우측

· 원발성 늑간신경통: 원인 불명, 드물

· 2차성 늑간신경통: 척추의 병변(흉추의 압박골절, 디스크, 골질의 증식), 대상포진 후 신경통, 당뇨병성 말초신경병증, 늑골 골절, 늑연골염 등

· 증상

- (∴신경에 문제가 생기는 것이므로 ⇒) 콧속 찌르는 듯한 or 전기가 통하는 것처럼 찌릿/ 심하면 살짝 만지기만 해도 통증

- 발작성 동통(통증 있다 없다 함): 발작시간은 짧고, 동통의 간헐기가 명확하지 않음

- 대부분 통증은 늑골신경 분포를 따라 한쪽에 발생 (양쪽은 드물)

- 동통이 호흡운동에 영향을 줌: 허리의 신전, 호흡, 해수 시 동통 증가

- 상응하는 피부구역의 감각 과민, 상응하는 늑골 끝에 압통

- 늑골신경염 시에는 감각장애, 운동장애, 근육위축 동반

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 기본 치료혈

· 懸鍾현중 竅陰규음 外關외관 三里삼리 支溝지구 章門장문 中封중봉 陽陵泉양릉천 行間행간 期門기문 陰陵泉음릉천

2) 변증치료

(1) 기울협통(氣鬱脇痛)

· 원인: 大怒氣逆及謀慮不決대노기역급모려불결, 皆冷肝火動甚개냉간화동심, 或性急多怒之人혹성급다노지인

· 증상: 脇痛협통, 脇肋引痛협력인통, 胸膈作痛흉격작통, 腹脇作痛복협작통, 兩脇痛양협통- +) '기울'의 증상들 같이 나타남

· 치법: 疏肝解鬱소간해울, 理氣止痛이기지통, 족궤음·족소양 위주, 임맥 배수 보좌. 침사법

· 치료혈: 膻中단중 氣海기해 肝俞간수 膽俞담수 行間행간 丘墟구허 足三里족삼리 支溝지구 陽陵泉양릉천 혹 中庭중정 肝俞간수 期門기문 俠谿협계 - 간담경혈자리 같이 씀

- ① 범산(泛酸, 위산이 올라옴): 加 胃俞위수

- ② 소매(少寐, 잠 잘 못 잠): 加 神門신문

(2) 어혈협통(瘀血脇痛)

· 원인: 因惡血停留於肝인악혈정류어간, 居於脇下거어협하

· 증상: 痛按之則痛益甚통안지즉통익심, 夜痛或午後痛甚야통혹오후통심, 脇痛固定不移협통고정불이, 持續不斷지속부단, 脇下脹痛拒按협하창통거안, 脈弦或細溢맥현혹세삼

- +) 어혈 증상 같이 생김: 야간/오후에 증상 심(야통혹오후통심), 협통 있는 부분 고정됨(협통고정불이)

· **치법:** 活血通絡활혈통락, 行氣止痛행기止痛

· **치법:** 족궤음·족소양 위주, 족태음 배수 보좌. 침사법

· **치료혈:** 太衝태충 陽陵泉양릉천 期門기문 行間행간 膈俞격수 章門장문 혹 大包 대포 京門경문 行間행간 膈俞격수 三陰交삼음교

- **질박손상(跌撲損傷):** 加 통증부위 취혈

(3) 담음협통(痰飲脇痛)

· **원인:** 痰飲流注於厥陰之經담음유주어궤음지경

· **증상:** 脇痛협통, 脇肋引痛협력인통, 咳嗽氣急해수기급, 漉漉有聲녹록유성

· **치법:** 祛痰止痛거담止痛

· **치료혈:** 中脘중완 足三里족삼리 章門장문 支溝지구 豐隆풍릉 期門기문

(4) 식적협통(食積脇痛)

· **원인:** 食積或痰飲結聚식적혹담음결취, 飲食太飽勞力음식태포노력

· **증상:** 脇下如杠梗起一條作痛협하여강경기일조작통(협하에 흥두꺼처럼 올라와서 작통), 發寒熱脇痛似有積塊발한열협통사유적괴

· **치법:** 消積止痛소적止痛

· **치료혈:** 足三里족삼리 中脘중완 胃俞위수 下脘하완

(5) 풍한협통(風寒脇痛)

· **원인:** 外感風寒외감풍한

· **증상:** 脇痛寒熱협통한열

· **치법:** 祛風寒止痛거풍한止痛

· **치료혈:** 足臨泣족임읍 中渚중저

(6) 습열협통(濕熱脇痛)

· **원인:** 肝膽濕熱간담습열

· **증상:** 右側脇痛우측협통, 如刺如灼여자여작(찌르는 듯한 작통), 急性發作時급성 발작시, 惡寒發熱오한발열, 口苦구고, 心煩심번, 惡心嘔吐오심구토, 舌苔厚膩설태 후니, 或黃膩혹황니, 脈弦數맥현삭

· **치법:** 清熱化濕청열화습, 疏肝利膽소간이담, 족궤음, 수족소양 위주. 침사법

· **치료혈:** 期門기문 日月일월 支溝지구 陽陵泉양릉천 太衝태충

- ① **열중(熱重):** 加 大椎대추

- ② **구오(嘔惡), 복창(腹脹):** 加 中脘중완 足三里족삼리

- ③ **심번(心煩):** 加 郄門극문

(7) 음허협통(陰虛脇痛)

· **원인:** 陰虛음허

· **증상:** 脇痛隱隱협통은은, 痛無定處통무정처(통증 있는 부분이 정해지지 않음), 無腹脹重着感무진창중착감, 面色少華면색소화, 顴紅관홍, 低熱저열, 自汗자한, 頭暈두훈, 目眩목현, 心悸심계, 舌質偏紅少苔설질편홍소태, 脈細數맥세삭 - 음허 증상 같이 나타남

· **치법:** 滋陰養血자음양혈, 和絡定痛화락정통, 족태음, 족양명, 수소음 위주. 침보법

· **치료혈:** 陰郄음극 心俞심수 血海혈해 三陰交삼음교

- ① **조열(潮熱):** 加 膏肓고황

- ② **두훈(頭暈):** 加 百會백회(隔布灸격포구)

제 15절. 鬱症울증

1. 개요

- **정의:** 정서적으로 서창(舒暢)하지 못하여 기기울체(氣機鬱滯)로 발생한 질환의 총칭
- **증상:** 심정억울(心情抑鬱), 정서불녕(情緒不寧), 이노욕곡(易怒欲哭), 흉부만민(胸部滿悶), 협륵창통(脇肋脹痛)
- **초기 발생:** 간기울체(肝氣鬱滯), 심비양허(心脾兩虛)
- **치료:** 기기소통(氣機疏通), 심비보익(心脾補益)
- **오래되면:** 기체(氣滯)가 혈어(血瘀)가 되고 간울생풍(肝鬱生風), 기울화화(氣鬱化火)하게 됨. 또한 화성음상(火盛陰傷), 비허생담(脾虛生痰), 심허신란(心虛神亂)하게 되어 상폐신(傷肺腎)하므로 ⇒ 조기에 치료해야 함
 - +) 울증이 오래되면 당연히 화로 진행
- 울증은 변화가 많고 다양한 범위를 포함
 - 정수검) “울(鬱)은 병의 고유한 명칭이 아니며, 백병이 이로 말미암아 발생된다.”
 - 주단계) 육울(六鬱): 기울, 혈울, 담울, 화울, 습울, 식울
 - 일반적으로 매핵기(梅核氣), 장조증(臟燥症) 포함
 - 두통, 불면, 심계, 유정 등 신체적인 병증 동반하는 경우 많음
 - 자침, 한약 외에도 정신적인 교육 및 심리치료가 매우 중요
 - 정신적인 소인 해결되지 않으면 치료 어려움
 - <임증지남> “울증은 환자의 정신상태에 의해 좌우되기 쉽다.”

2. 서양의학적 이해

1) 울증

- ① 자율신경계 이상 증후군 ex. 위장 자율신경장 애증
 - 위장자율신경장애증(위장신경관능증): 자율신경 기능이상으로 위/장 기능에 장애가 생기는 병

→ 위 자율신경장애증: 애기(噯氣), 식후구토, 상복부의 포만감/불쾌감, 위산과다 등

→ 장 자율신경장애증: 정서이상, 식후에 바로 설사, 복통, 복창, 장명, 변비

→ 대부분 불면, 두통, 흥민, 정신혼란, 번조불안 등 전신성 자율신경장애소견 동반

→ 대개 만성, 여성에 많음

· ② 정신과 질환과 유관: 신경 쇠약 및 히스테리, 반응성 정신병 등

- +) 반응성 정신병: 특정 상황이 왔을 때 발생하는 것 ex. 고산병, 스트레스 너무 많이 받을 때

· ③ 갱년기 장애의 종합적인 증상

3. 한의학적 고찰: 치료

1) 변증치료

(1) 간기울결(肝氣鬱結): =초기 증상 → 심해지면 기울화화

· **증상:** 精神抑鬱정신억울, 胸悶脇痛흉민협통, 腹脹嘔氣복창구기, 不思飲食불사음식, 惡心嘔吐오심구토, 大便不調대변부조, 舌苔薄膩설태박니, 脈弦맥현

· **치법:** 疎肝理氣소간이기

· **치료혈:** 太衝태충 神門신문 大陵대릉 三陰交삼음교

(2) 기울화화(氣鬱化火)

· **증상:** 性情急躁易怒성정급조이노(화병 증상까지 같이 나타남), 胸脇홍협, 頭痛두통, 口苦구고, 口乾구건, 嘈雜吞酸 조잡탄산, 大便秘結대변비결, 目赤耳鳴목적이명, 舌苔黃설태황, 舌質紅설질홍, 脈弦數맥현삭

· **치법:** 清肝瀉火청간사화

· **치료혈:** 太衝태충 行間행간 神門신문 大陵대릉 三陰交삼음교

(3) 심비양허(心脾兩虛)

- **증상:** 多思善疑다사선의(생각(걱정), 의심 많음), 不眠불면, 多夢다몽, 面蒼白면창백, 不思飲食불사음식, 心悸심계, 眩暈현훈, 記憶力減退기억력감퇴, 神疲氣短신피기단, 月經不調월경부조, 舌苔薄설태박, 舌質淡설질담, 脈細弱맥세약
- **치법:** 健脾養心건비양심, 益氣補血익기보혈
- **치료혈:** 神門신문 大陵대릉 三陰交삼음교 陰陵泉음릉천

(4) 심허신란(心虛神亂)

- **증상:** 精神恍惚정신황홀, 善悲선비(쉽게 눈물 흘림), 善哭선곡(쉽게 곡함(울)), 善欠선흠(쉽게 하품함), 脈細맥세
- **치법:** 養心安神양심안신
- **치료혈:** 內關내관 神門신문 合谷합곡 太衝태충

(5) 음허화왕(陰虛火旺)

- **증상:** 心悸심계, 失眠실면, 心煩易怒심번이노, 頭暈頭痛두훈두통, 遺精유정, 帶下대하, 舌質紅少苔설질홍소태, 脈弦細而數맥현세이삭 - 음기 허한 증상 + 화의 증상 같이 나타남
- **치법:** 養陰瀉火양음사화
- **치료혈:** 太衝태충 神門신문 大陵대릉 湧泉용천 三陰交삼음교

(6) 담기울결(痰氣鬱結)

- **증상:** 咽喉部인후부 梅核症狀매핵증상, 嚥不下咯不出연불하객불출, 胸悶흥민, 脘脰脇痛완장협통, 舌苔薄설태박, 脈弦滑맥현활
- +) 인후부 매핵증상: 인후부에 뭔가 걸린 듯함
- +) 연불하객불출: 삼켜도 잘 안 내려가고, 뱉어도 잘 안 뱉어짐
- **치법:** 理氣化痰이기화담
- **치료혈:** 內關내관 中脘중완 豐隆풍릉 太衝태충 陽陵泉양릉천

(7) 매핵기(梅核氣)

- **증상:** 情志抑鬱정지억울, 胸悶흥민, 噫氣애기, 咽中不適如有物阻인중부적여유물조, 吞不下咯不出탄불하객불출, 善太息선태식, 舌苔薄白膩脈弦或滑설태박백니맥현혹활
- +) 인후부에 뭔가 걸려있는 듯하면서(인중부적여유물조), 삼켜지지 않고 뱉어도 뱉은 듯하지 않음(탄불하객불출)
- **치법:** 疏肝解鬱소간해울, 清火化痰청화화담, 임맥·족궐음·족양명·수태음·수소음경혈 取. 평보평사(平補平瀉)
- **치료혈:** 太衝태충 膻中단중 豐隆풍릉 魚際어제 神門신문
- ① 인후건통(咽喉乾痛): 加 天鼎천정 商陽상양
- ② 불면(不眠): 加 厲兌여태(灸)

· +) 담기울결 vs 매핵기 구별

- 담기울결: =역류성 식도염
- 위산이 올라오면서 인후부 쪽에 이물감이 있으면서 불편한 것
- 매핵기: 정신적인 문제로 목에 삼켜지지 않는 이물감이 있는 것
- 즉 스트레스를 받아 뭔가 말하고 싶은데 말하지 못해 목에 걸려있는 듯한 느낌
- 역류성 식도염과 비슷한 증상이 나타나지만 스트레스 증상이 뚜렷하게 나타남: 역류성 식도염은 실제로 있을 수도 있고 없을 수도 있음

(8) 장조증(臟燥症)

- **증상:** 精神恍惚不寧정신황홀불녕, 情志失常정지실상, 時時悲泣시시비읍, 喜怒無常희노무상, 舌苔薄설태박, 脈細맥세
- +) 쉽게 울었다가, 쉽게 화냈다가, 쉽게 기뻐했다가
- +) 히스테리성 발작, 갱년기와 유사

- **치법:** 滋陰益氣자음익기, 養心安神양심안신, 배수·수궤음·족태음경혈 取. 보법
- **치료혈:** 膈俞격수 腎俞신수 心俞심수 內關내관 三陰交삼음교
 - ① **신지몽롱(神志朦朧):** 加 人中인중 中衝중충
 - ② **사지진전(四肢震顫):** 加 太衝태충 陽陵泉양릉천
 - ③ **목강(木僵):** 加 百會백회 大陵대릉
 - ④ **구금(口噤):** 加 合谷합곡 頰車협거
 - ⑤ **애역(呃逆):** 加 中脘중완 足三里족삼리
 - ⑥ **실어(失語):** 加 通里통리
 - ⑦ **이롱(耳聾):** 加 聽會청회 中渚중저

4. Tip

- 현대의학의 억병(癥病)(화병, 울화병)에 해당. 일종의 심인성 정지병(情志病)
 - +) 심리적 치료도 중요: 침 치료는 일시적. 정신적 문제가 해결되거나, 약을 써서 해결해줘야 함
 - 환자의 의식은 명료하므로, 치료할 때 말로 암시하는 것이 중요

· 육울(六鬱)

① 기울(氣鬱)	情志鬱結정지울결 肝氣不舒간기불서	胸滿脇痛흉만협통, 脈沈澁맥침삽
② 담울(痰鬱)	痰氣鬱結담기울결	胸滿흉만, 動則喘急或咳동즉천급혹해, 起臥怠惰기와태타, 寸脈沈滑촌맥침활
③ 습울(濕鬱)	濕因氣滯습인기체 鬱而不散울이불산	周身關節走痛주신관절주통, 首如物蒙 수어물몽, 足重족중, 脈沈濡맥침유
④ 식울(食鬱)	氣機不利기불리 食滯不消식체불소	脘腹飽脹완복포창, 噯氣酸腐애기산부, 不能食불능식, 大便不調대변부조, 甚則黃疸심즉황달, 鼓脹고창, 痞塊비괴, 脈氣口脈緊盛맥기구맥긴성
⑤ 열울(熱鬱)	諸鬱久而不癒제울구이불유 多可火熱而成다가화열이성	頭昏두혼, 目眩목현, 口乾舌燥구건설조, 小便赤濁소변적탁, 脈沈數맥침삭
⑥ 혈울(血鬱)	暴怒捻閃폭노염섬 飢飽不調기포부조	四肢無力能食사지무력능식, 小便淋소변림, 大便紅대변홍, 脈沈或芤맥침혹규

- +) 정신과 질환이 있는 경우, 이 때문에 병발하는 증상을 같이 많이 호소함
- **병발 증상:** ex. 만성 위염/위암, 설사, 불면, 애기 등
- ex. 심리적 문제가 있으면 단순한 근골격계 질환도 잘 낫지 않거나 치료 기간 길어짐
- ∴ 심리적 요인도 치료에 있어 중요하므로, 꼭 짚어서 치료해줘야 하는 경우 많음